

Pr BAHLOUL Mabrouk

1/ La physiopathologie de l'état de choc septique comporte :

- A. Une libération de cytokines anti inflammatoires
- B. Une mise en jeu uniquement de l'immunité cellulaire
- C. Une activation du système fibrinolytique
- D. Une augmentation de la perméabilité capillaire
- E. Une distribution appropriée des flux sanguins locorégionaux

Réponse : A-C-D

2/ Le profil hémodynamique du choc septique est caractérisé par :

- A. Une extraction d'oxygène diminuée
- B. Une pression capillaire pulmonaire augmentée
- C. Un débit cardiaque toujours augmenté
- D. Une pression veineuse centrale basse
- E. Une différence artério-veineuse en oxygène basse

Réponse : A-D-E

3/ L'antibiothérapie dans l'état de choc septique :

- A. Ne doit jamais être administrée avant de réaliser les prélèvements bactériologiques
- B. Doit être poursuivie pendant au moins 14 jours
- C. Doit toujours associer une β lactamine à large spectre et un aminoside
- D. Doit être administrée idéalement dans la première heure de la prise en charge
- E. Doit être administrée obligatoirement par voie intraveineuse

Réponse: D-E

4/ Aux urgences, quel résultat biologique qui reflète le mieux la gravité d'un patient en état de choc septique?

- A. Leucocytes = 22 000 /mm³
- B. Procalcitonine (PCT) = 2,5 mmol/L
- C. CRP = 40 mmol/L
- D. Lactate = 5 mmol/L
- E. Phosphore = 1,8 mmol/L

Réponse : D

5/ Au cours de l'état de choc septique, quelles sont les propositions exactes ?

- A. La transfusion de culots globulaires est recommandée lorsque l'hémoglobine est < 5 g/dl
- B. L'objectif de la transfusion de culots globulaires est un taux d'hémoglobine entre 7 et 9 g/dl en l'absence de pathologie coronarienne
- C. La transfusion de plasma frais congelé est conseillée du fait des anomalies du bilan de coagulation
- D. La transfusion de plaquettes est indiquée lorsqu'elles sont inférieures à 10 000/mm³
- E. Les troubles de coagulation contre indique l'éradication chirurgicale du foyer infectieux

Réponse : B-D

6/ Le choc septique :

- A. Se définit comme un état septique sévère avec hypotension non corrigée par le remplissage
- B. Se présente dans la majorité des cas avec un débit cardiaque normal ou élevé
- C. Est considéré à priori comme toujours hypovolémique
- D. S'accompagne très fréquemment d'une dépression myocardique
- E. Nécessite en premier lieu l'administration de dopamine avant le remplissage vasculaire

Réponse : B-C-D

7/ Vous êtes au chevet d'un malade en état de choc avec une auscultation pulmonaire normale et une turgescence des veines jugulaires.

Quel est le diagnostic à évoquer en priorité ?

- A. Choc hémorragique
- B. Embolie pulmonaire
- C. Dissection aortique
- D. Choc anaphylactique
- E. Choc septique

Réponse : B

8/ Les éléments qui orientent vers une infection par des bactéries multi-résistantes sont :

- A. Patients hémodialysés
- B. Un séjour hospitalier de plus de 2 jours durant les 7 derniers mois
- C. Une prise d'antibiotiques durant les 3 derniers mois
- D. Antécédents de chirurgie cardiaque valvulaire datant de plus de 1 an
- E. Patients immunodéprimés

Réponse : A-C-E

9/ Les cristalloïdes :

- A. Sont les solutés de remplissage à utiliser en première intention en cas de choc septique
- B. Ne diffusent pas dans le secteur interstitiel
- C. Ont un faible pouvoir d'expansion volémique comparativement aux colloïdes
- D. N'entraînent pas d'œdème
- E. Peuvent entraîner une acidose hyperchlorémique

Réponse : A-C-E

10/ Concernant le traitement antibiotique en cas de choc septique :

- A. Une bithérapie à large spectre est envisagée
- B. La durée de traitement est de 7 à 10 jours
- C. Une antibiothérapie visant les germes multirésistants est toujours indiquée
- D. Une réévaluation est indiquée 4 jours après le début du traitement
- E. L'antibiothérapie est l'élément pronostic majeur dans la prise en charge du choc septique

Réponse : B-E

11/ Le score SOFA :

- A. Comporte 5 défaillances d'organes cotées chacune de 0 à 4
- B. Un score ≥ 2 est associé à un risque de mortalité de 10%
- C. Est utilisé en milieu médical et en réanimation
- D. Un score simplifié et facile qSOFA permet de faire le tri en urgence
- E. Un score > 2 permet de définir le sepsis

Réponse : B-D

12/ La vasoplégie observée lors de l'état de choc septique est secondaire à l'action de plusieurs médiateurs, lesquels ? :

- A. Le monoxyde d'azote
- B. L'histamine
- C. L'endothéline
- D. Le thromboxane
- E. Les bradykinines

Réponse : A- B- E

13/ La CIVD observée lors de l'état de choc septique est secondaire à :

- A. L'augmentation de la déformabilité des globules rouges
- B. La diminution de la viscosité sanguine
- C. L'ouverture des shunts artério-veineux
- D. Ralentissement microcirculatoire
- E. L'inhibition des facteurs de coagulation

Réponse : C-D

14/ Parmi les mécanismes adaptatifs à l'étage de la macro-circulation au cours l'état de choc septique :

- A. Une stimulation des barorécepteurs aortiques et carotidiens
- B. Une inhibition du système sympathique
- C. Une inhibition du système rénine-angiotensine
- D. Une augmentation du taux circulant de la vasopressine
- E. Les mécanismes adaptatifs intéressent surtout les territoires vasculaires riches en récepteurs α

Réponse : A-D-E

15/ La défaillance hémodynamique au cours du choc septique peut être liée :

- A. Au dépassement des effets adaptatifs liés à la stimulation parasympathique
- B. Au syndrome de fuite capillaire
- C. À l'hypo réactivité vasculaire aux agents vasoconstricteurs
- D. À une dysfonction systolique isolée
- E. À l'hypovolémie absolue

Réponse : B-C-E

16/ L'atteinte myocardique au cours de l'état de choc septique est :

- A. Tardive
- B. Univentriculaire
- C. Systolo-diastolique
- D. Irréversible
- E. D'intensité variable

Réponse : C-E

17/ Au cours de l'état de choc septique, il se produit :

- A. Une insuffisance surrénalienne absolue
- B. Une insulino-résistance
- C. Une diminution de la viscosité sanguine
- D. Une augmentation de la déformabilité des globules rouges
- E. Une dysfonction mitochondriale

Réponse : B-E

18/ L'état de choc septique associe :

- A. Une diminution des résistances vasculaires systémiques
- B. Une augmentation des pressions de remplissage
- C. Une diminution de l'extraction en oxygène
- D. Une augmentation de la différence artério-veineuse
- E. Une augmentation de l'index cardiaque

Réponse : A-C-E

19/ Les éléments qui orientent vers une infection par des bactéries multi résistantes (BMR) sont :

- A. Un séjour hospitalier de 24 heures durant le mois dernier
- B. Un patient porteur de cathéter jugulaire de dialyse
- C. Antécédent de remplacement valvulaire datant d'un an et demi
- D. Une prise d'antibiotiques durant les 3 derniers mois
- E. Un patient sous chimiothérapie

Réponse : B-D-E

20/ À propos le remplissage vasculaire au cours de l'état de choc septique :

- A. Il est recommandé de réaliser un remplissage vasculaire par 20 ml/Kg de colloïdes pendant la première heure
- B. Le sérum salé isotonique à 9‰ expose au risque d'acidose métabolique hyperchlorémique
- C. Il est préféré d'utiliser des solutés balancés (exemple : Ringer lactate)
- D. Les cristalloïdes sont à utiliser en première intention
- E. L'albumine humaine n'a pas d'indication au cours de l'état de choc septique

Réponses: C- B-D

21/ À propos le traitement de l'état de choc septique, quelles sont les propositions exactes ?

- A. L'absence de réponse à un remplissage vasculaire bien conduit doit faire envisager l'introduction d'un agent inotrope positif
- B. La noradrénaline est la catécholamine de choix
- C. La vasopressine peut être prescrite en remplacement à la noradrénaline
- D. La dobutamine est prescrite en cas de dysfonction myocardique avec un bas débit cardiaque malgré l'expansion volémique.
- E. L'agent inotrope positif est souvent nécessaire au cours de l'état de choc septique

Réponse : B-D

22/ À propos la prise en charge de l'état de choc septique, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Une antibiothérapie probabiliste doit être débutée dans les 4 heures qui suivent le diagnostic
- B. L'antibiothérapie peut être administrée par voie orale
- C. Une association d'antibiotiques à large spectre doit être envisagée en cas de suspicion d'infection par des bactéries multi résistantes
- D. En cas de sepsis à point de départ endo vasculaire, l'accès vasculaire peut être maintenu
- E. Deux hémocultures doivent être réalisées avant de débiter l'antibiothérapie

Réponse : C-E

23/ La corticothérapie au cours de l'état de choc septique :

- A. Indiquée du fait d'une insuffisance surrénalienne absolue associée à l'état de choc
- B. Indiquée en cas de choc septique non stabilisé par le remplissage vasculaire et les drogues vasopresseurs
- C. Hémisuccinate d'hydrocortisone à la dose de 200 mg/j pendant 3 jours
- D. Dégression progressive des doses
- E. Peut être administrée par voie orale

Réponse : B

24/ Les objectifs à atteindre lors de la prise en charge du choc septique sont :

- A. Une PVC entre 12 et 18 mmHg
- B. Une PAM > 85 mmHg
- C. Un débit urinaire > 0,5ml/kg/h
- D. Une SvO₂ < 60%
- E. Une amélioration de la clairance des lactates

Réponse : C-E

25/ Les éléments qui font partie du score de SOFA :

- A. La cytolyse hépatique
- B. La leucopénie
- C. L'hypoxémie
- D. L'hypotension
- E. L'altération de l'état de conscience

Réponse : C-D-E

26/ Au cours de la phase hyperkinétique d'un choc septique, le profil hémodynamique observé peut inclure :

- A. Un débit cardiaque élevé
- B. Une extraction basse d'oxygène
- C. Des résistances artérielles systémiques basses
- D. Une PVC augmentée
- E. Une PAPO basse

Réponse : A-B-C-E